



Dossier Médical

BOSTIC MAMO

Identité : Bostic Mamo
Date de naissance : 1 Janvier 2001
Téléphone : xxx



ADMISSION: 15 JAN 2026 À 20:56

SORTIE: 15 JAN 2026 À 20:57

MOTIF DE CONSULTATION

Patient amené aux urgences suite à plaies par arme à feu multiples touchant les deux jambes, avec douleur intense, saignements, difficulté à marcher, et suspicion de lésion osseuse / vasculo-nerveuse, notamment à droite (fragmentation).

DIAGNOSTIC

1) Jambe droite – 2 impacts + fragment Deux plaies par balle au membre inférieur droit, dont au moins une avec fragmentation (éclats métalliques / osseux). Suspicion de : fracture comminutive (tibia/fibula ou fémur selon localisation) lésions musculaires importantes (mollet / quadriceps) atteinte vasculaire possible (artère poplitée / tibiale) atteinte nerveuse (nerf fibulaire commun → pied tombant possible) risque de syndrome des loges (urgence secondaire) 2) Jambe gauche – 1 impact Plaie pénétrante par arme à feu de la jambe gauche Risques associés : atteinte musculaire simple fracture non déplacée possible lésion artérielle/veineuse moins probable mais à vérifier





TRAITEMENT

A) Prise en charge immédiate (urgence / trauma) Mise en salle de déchocage si saignement important ou choc Oxygène si besoin + monitoring (TA, FC, SpO₂) 2 voies veineuses + prélèvements sanguins : NFS, coagulation, lactates groupage/RAI (si transfusion potentielle) Antalgie IV (morphine titrée ou équivalent) Pansements compressifs Si hémorragie externe massive : garrot de cuisse temporaire (surtout jambe droite) Prévention hypothermie (couverture, réchauffement) B) Évaluation vasculo-nerveuse (super important) Sur chaque jambe : pouls pédieux et tibial postérieur recoloration capillaire température / couleur du pied sensibilité + motricité (orteils / cheville) ➡ Si pouls absent ou jambe froide : urgence vasculaire C) Imagerie et examens Radiographies jambe droite + genou + cheville Radiographies jambe gauche Si suspicion fracture complexe : scanner Si doute sur artère : angioscanner ou Doppler artériel ✓ Traitement spécifique 1) Jambe droite (2 balles + fragments) Objectif : sauver le membre + éviter infection/complications Nettoyage chirurgical (débridement) des tissus nécrosés/souillés Extraction des fragments : ✓ uniquement ceux accessibles / dangereux ✗ on ne retire pas forcément tous les micro-fragments si trop profonds et stables Si fracture : immobilisation immédiate (attelle) souvent fixateur externe en urgence si fracture ouverte/comminutive puis chirurgie secondaire (clou/plaques) après stabilisation Surveillance syndrome des loges : douleur disproportionnée mollet dur "bois" paresthésies ➡ si confirmé : aponévrotomie (fasciotomie) en urgence 2) Jambe gauche (1 balle) Selon gravité : si trajet simple sans fracture : nettoyage + pansement stérile surveillance hématome/saignement si fracture ou atteinte profonde : immobilisation chirurgie orthopédique si nécessaire ✓ Antibiotiques / prévention infection Plaies par balle + fragments = risque infectieux élevé : Antibiothérapie prophylactique souvent céphalosporine (selon protocoles) plus large si fracture ouverte / souillure importante Vaccin antitétanique immunoglobulines si statut inconnu ou incomplet ✓ Gestion douleur + soins associés antalgiques IV puis relais per os prévention thrombose (HBPM) si immobilisation prolongée kiné / rééducation dès que possible contrôle hémoglobine si saignement important



ADMISSION: 21 JAN 2026 À 00:02

SORTIE: 25 JAN 2026 À 18:50

MOTIF DE CONSULTATION

2 blessures par arme à feu

DIAGNOSTIC

Une blessure par balle à la cuisse gauche, avec orifice d'entrée et de sortie, sans rétention de projectile. Une blessure par balle au niveau du tibia droit, avec projectile non ressorti, nécessitant une intervention chirurgicale.

TRAITEMENT

L'exploration et le nettoyage chirurgical de la plaie de la cuisse gauche, avec contrôle de l'hémostase. L'exploration de la plaie du tibia droit et le retrait du projectile. Le débridement, la désinfection des plaies et la suture. La vérification de l'absence de lésions vasculaires, nerveuses ou osseuses associées. L'opération s'est déroulée sans complication, tant sur le plan chirurgical qu'anesthésique. Aucune complication peropératoire n'a été constatée.



ADMISSION: 21 JAN 2026 À 00:02

SORTIE: 25 JAN 2026 À 18:50

MOTIF DE CONSULTATION

2 blessures par arme à feu

DIAGNOSTIC

Une blessure par balle à la cuisse gauche, avec orifice d'entrée et de sortie, sans rétention de projectile. Une blessure par balle au niveau du tibia droit, avec projectile non ressorti, nécessitant une intervention chirurgicale.

TRAITEMENT

L'exploration et le nettoyage chirurgical de la plaie de la cuisse gauche, avec contrôle de l'hémostase. L'exploration de la plaie du tibia droit et le retrait du projectile. Le débridement, la désinfection des plaies et la suture. La vérification de l'absence de lésions vasculaires, nerveuses ou osseuses associées. L'opération s'est déroulée sans complication, tant sur le plan chirurgical qu'anesthésique. Aucune complication peropératoire n'a été constatée.





ADMISSION: 28 JAN 2026 À 00:33

SORTIE: 28 JAN 2026 À 19:20

MOTIF DE CONSULTATION

Blessure part balle

DIAGNOSTIC

Présence de corps étrangers (balles) au niveau du mollet et de l'abdomen, nécessitant une extraction chirurgicale afin d'éviter les complications et d'assurer une bonne cicatrisation.

TRAITEMENT

Le patient a été installé au bloc opératoire sous anesthésie générale. Après préparation et désinfection des zones opératoires, une première exploration a été réalisée au niveau du mollet. La balle a été localisée puis retirée sans difficulté. Aucun dommage majeur musculaire, vasculaire ou nerveux n'a été constaté. Un lavage soigneux a été effectué. Une seconde exploration a ensuite été réalisée au niveau de l'abdomen. La balle a été identifiée et extraite avec succès. L'exploration abdominale n'a pas mis en évidence de lésion grave des organes internes. Un lavage abondant a été réalisé et l'hémostase a été correctement assurée. Les plaies ont été refermées après contrôle final.



**ADMISSION: 5 FEB 2026 À 00:46****MOTIF DE CONSULTATION**

Admission en urgence pour blessure par balle au bras droit, calibre 5.56, avec saignement important.

DIAGNOSTIC

Atteinte veineuse responsable d'une hémorragie significative. Atteinte musculaire du bras droit. Absence d'atteinte artérielle majeure identifiée après exploration. Absence de fracture osseuse associée. Patient stabilisé sur le plan hémodynamique après prise en charge.

TRAITEMENT

Prise en charge chirurgicale en urgence. Nettoyage et exploration approfondie de la trajectoire balistique. Manchonnage veineux réalisé afin de restaurer la continuité de la veine lésée. Contrôle efficace de l'hémostase. Suture des lésions musculaires du bras droit. Suture cutanée après stabilisation locale. Pose d'un pansement stérile compressif. Antalgie adaptée administrée. Antibioprophylaxie instaurée.

ADMISSION: 7 FEB 2026 À 00:18**MOTIF DE CONSULTATION**

Admission en urgence pour traumatisme crânien

DIAGNOSTIC

Prise en charge neurochirurgicale en urgence. Libération de l'œdème sous-dural afin de réduire la pression intracrânienne. Application d'un dispositif de protection de la fracture crânienne, favorisant la cicatrisation osseuse. Pose d'un drain pour prévenir la réaccumulation de liquide. Suture du cuir chevelu après stabilisation locale. Surveillance neurologique continue.

TRAITEMENT

Hospitalisation pour la nuit en milieu surveillé. Surveillance des constantes et de l'état de conscience. Test cognitif programmé au réveil afin d'évaluer les conséquences neurologiques du traumatisme

Medecin Elias Varn





ADMISSION: 11 FEB 2026 À 01:26

SORTIE: 16 FEB 2026 À 23:00

MOTIF DE CONSULTATION

Fusillade

DIAGNOSTIC

Patient arrivé suite à une fusillade. Blessure par balle à la gorge

TRAITEMENT

Premier soins effectué par la LSPD. Bandage Hémostatique placé dans la plaie. Arrivé à l'hôpital, il est passé en salle opératoire, nettoyage de la plaie et suture. Le patient reste en observation pour la nuit

ADMISSION: 16 FEB 2026 À 23:18

MOTIF DE CONSULTATION

Crise de manque lié à la Weed (Elias Varb)

DIAGNOSTIC

Le patient était très agité à en devenir une danger pour lui même ou autrui. Il a été contraint de fumer plusieurs joints de drogue basé sur la weed.

TRAITEMENT

Un médicament palliatif lui a été prescrit, il devra revenir dans 48h afin de faire le suivi de son état.

ADMISSION: 17 FEB 2026 À 22:45

MOTIF DE CONSULTATION

Blessure au bras par arme contondante (Hana Foster)

DIAGNOSTIC

Plaie ouverte épaule droite, plaie non profonde aucun tissus musculaire/cartilage touché

TRAITEMENT

Désinfection et suture de la plaie

